

Síntomas psiquiátricos más frecuentes en personas mayores

J.-C. Roy, G. Robert

Resumen: El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos psiquiátricos en los ancianos requieren un enfoque sistemático, dada la variabilidad de su expresión clínica, la frecuente presencia de afecciones médicas crónicas intercurrentes y el mayor riesgo de deterioro cognitivo. La evaluación médica implica tanto un diagnóstico clínico riguroso de los trastornos presentados como de los factores de riesgo asociados, que suelen ser inseparables de los síntomas psiquiátricos. La atención se centra entonces en la etiología de los trastornos, la resolución de los factores precipitantes y de mantenimiento y la actuación sobre el entorno físico y humano del paciente. En este artículo se examinan algunos de los signos y síntomas psiquiátricos que se observan con frecuencia en los ancianos, para ilustrar el enfoque médico que puede conducir a un tratamiento adecuado de estos trastornos.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares
Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en el contenido que publica, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Síntomas psiquiátricos; Trastornos de conducta; Geriatría; Salud mental

Plan

■ Introducción	1
■ Enfoque diagnóstico de los síntomas psiquiátricos en ancianos	1
Evaluación de los factores de riesgo y precipitantes de los SSP	2
Etiologías más frecuentes de los SSP	2
■ Principios de tratamiento	4
Tratamiento médico de la etiología y los factores precipitantes	4
Medidas medicosociales	4
Apoyo a los cuidadores	4
Tratamiento psiquiátrico sintomático	4
■ Ejemplos de signos y síntomas psiquiátricos frecuentes	5
Agitación	5
Ansiedad	5
Apatía	6
Ideas suicidas	6
Síntomas psicóticos	6
Trastornos de las funciones instintivas	6
■ Conclusión	6

■ Introducción

Según un informe de 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15% de la población mundial mayor de 60 años sufre un trastorno de salud mental ^[1]. La expresión de los signos y síntomas psiquiátricos (SSP) es compleja en estos pacientes debido

a la interacción de los factores biopsicosociales que definen la salud mental, en particular las condiciones de vida y las comorbilidades médicas inherentes al envejecimiento. Las consecuencias son significativas en términos de dependencia y mortalidad, ya que el 6,6% de las discapacidades se atribuyen a trastornos psíquicos o neurológicos, de los cuales los más comunes son la demencia y la depresión; además, alrededor de un 25% de los suicidios en todo el mundo afectan a personas de 60 años o más ^[1]. Por lo tanto, la evaluación de los SSP en los ancianos debe seguir un método sistemático. En este artículo se presenta un enfoque para evaluar los trastornos y los factores que intervienen en la expresión de los SSP, antes de describir las etiologías más frecuentes. Después se presentarán las herramientas de tratamiento médico y psicosocial. Por último, se ilustrarán las características diagnósticas y terapéuticas específicas en las personas ancianas, utilizando ejemplos de SSP frecuentes. Los elementos y argumentos utilizados aquí se ajustan al excelente trabajo de Dorey et al ^[2].

■ Enfoque diagnóstico de los síntomas psiquiátricos en ancianos

El tratamiento de los SSP requiere una evaluación rigurosa en la que participen el médico, el paciente, los cuidadores familiares y/o profesionales. El primer paso consiste en enumerar los SSP, describirlos (tipo, frecuencia, duración, intensidad) y evaluar su repercusión en la persona y en quienes la rodean. Deben conocerse

los antecedentes médicos generales, neurológicos y psiquiátricos del paciente. Sea cual sea el trastorno, hay que aclarar el contexto en el que se produce buscando factores de riesgo y precipitantes.

Evaluación de los factores de riesgo y precipitantes de los SSP

Factores somáticos

Incluyen factores somáticos como la descompensación de una enfermedad crónica, una enfermedad aguda, la presencia de dolor o la polimedicación. Las causas más frecuentes de SSP son las infecciones, la impactación fecal, el globo vesical, los trastornos hidroelectrolíticos y la iatrogenia. Las deficiencias sensoriales dificultan la interacción de las personas con su entorno, lo que puede dar lugar a conductas inadecuadas. Por último, hay que tener en cuenta los factores que influyen en la autonomía, como los factores de riesgo de caídas: cardiovasculares, osteoarticulares, neuromusculares y neurológicos, además de las causas antes mencionadas. Los retrasos en el tratamiento de la incontinencia urinaria o fecal, una hidratación subcutánea sistemática inadecuada o un reposo prolongado en cama también pueden favorecer las conductas regresivas.

Factores neurológicos

A menudo están presentes factores neurológicos, como un deterioro cognitivo menor o mayor, que deben especificarse mediante una exploración neurológica rigurosa, una evaluación neuropsicológica y pruebas de imagen cerebral. Las imágenes cerebrales revelan con frecuencia lesiones microvasculares inespecíficas en los SSP de los ancianos. Las secuelas de caídas deben buscarse en las imágenes (hematoma extradural), al igual que cualquier anomalía específica (atrofia cortical localizada, hidrocefalia).

Factores psiquiátricos

Deben investigarse los factores psiquiátricos. En personas con antecedentes psiquiátricos conocidos (trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, esquizofrenia), el deterioro cognitivo puede favorecer la descompensación y modular la expresión clínica de los síntomas. Si no se encuentran antecedentes psiquiátricos, la anamnesis puede revelar argumentos a favor de una vulnerabilidad psiquiátrica no reconocida pero compensada de forma adecuada a lo largo de la vida.

Factores psicológicos

Tener en cuenta los factores psicológicos ayuda a comprender la génesis de los SSP y a elaborar una atención personalizada. Hay que tener en cuenta los patrones de apego temprano, los acontecimientos vitales y el perfil de «personalidad premórbida». La presencia de trastornos cognitivos puede exacerbar los rasgos de personalidad previos cuando se supera la capacidad de adaptación individual [3].

Factores medioambientales

Los factores ambientales humanos y materiales son esenciales. En el caso de los pacientes con discapacidad, es primordial establecer una relación con los cuidadores y proporcionarles apoyo. La tolerancia de los cuidadores a la discapacidad de su familiar está determinada por su perfil psicológico, su disposición a pedir ayuda, su estado general de salud, la calidad previa de la relación con la persona cuidada, su conocimiento de la enfermedad y la gravedad de los problemas de conducta. La escasa aceptación y comprensión de los trastornos puede dar lugar a actitudes que contribuyan a mantener los síntomas y a dificultar el apoyo [4]. El agotamiento de la familia y los amigos es un factor de riesgo para el maltrato del paciente. También hay que tener en cuenta la calidad del entorno físico. Las condiciones de vida que aumentan el riesgo de caídas (suelos resbaladizos, mala iluminación, obstáculos en el suelo), la ropa inadecuada (ropa demasiado larga) o los muebles inadecuados (camas demasiado altas o demasiado bajas) pueden contribuir a aumentar los problemas al repercutir en la autonomía.

Etiologías más frecuentes de los SSP

Un síntoma psiquiátrico o un trastorno conductual no apuntan por sí solos a una causa específica, en particular psiquiátrica. La búsqueda de criterios diagnósticos es fundamental para un tratamiento eficaz.

Confusión

La confusión es una urgencia médica que se manifiesta por la aparición súbita o rápidamente progresiva (en minutos, horas o días) de trastornos psicoconductuales **fluctuantes**. Estos síntomas incluyen déficits atencionales en forma de trastornos de la memoria de trabajo, desorganización cognitiva o trastornos de la memoria a corto plazo. También puede haber inestabilidad conductual, con agitación, deambulación e inversión del ciclo nictemeral. Son frecuentes los síntomas psicóticos en forma de delirios, fabulaciones o alucinaciones, la mayoría de las veces visuales. La inestabilidad tímica puede asociarse a labilidad del humor, agresividad o perplejidad. Hay muchas causas de confusión; los principales factores de riesgo son los trastornos neurocognitivos mayores, el aislamiento, los déficits sensoriales y la deshidratación. El tratamiento es ante todo preventivo [5]. El tratamiento curativo se centra en la causa del trastorno y en los factores que lo mantienen. Para reducir los SSP durante la investigación etiológica, se pueden instaurar tratamientos antipsicóticos cuando se detecten síntomas psicóticos. Su uso debe limitarse en el tiempo, con el objetivo de sedar la agitación y la reactividad ansiosa asociadas a los síntomas psicóticos. La melatonina es una opción interesante para reducir la agitación y los trastornos del ritmo nictemeral, sin las confusiones que provocan las benzodiazepinas o los hipnóticos afines.

Dificultades adaptativas

Las reacciones a situaciones estresantes constituyen un segundo factor que suele asociarse a los SSP. Según el *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-5* (DSM-5) [6], se diagnostica un **trastorno de adaptación** si se presentan síntomas emocionales o conductuales después de 3 meses de exposición a factores de estrés claramente identificados. Los síntomas adoptan la forma de malestar desproporcionado a la intensidad del factor estresante, que conduce a una alteración del funcionamiento social. Estos síntomas no cumplen los criterios de enfermedad psiquiátrica y no persisten más de 6 meses después de la desaparición del factor estresante. El trastorno de adaptación no incluye el duelo normal, que es frecuente en los ancianos. El **duelo normal** se distingue del **duelo complejo persistente** por su duración inferior a 4 meses y sus repercusiones funcionales. El duelo complejo persistente incluye síntomas de duelo graves que persisten durante al menos 12 meses. Los episodios depresivos y el riesgo de suicidio deben evaluarse de forma sistemática. La presencia de baja autoestima, tristeza que se extiende más allá de la pérdida del ser querido e ideación suicida apoyada por sentimientos de culpa o indignación sugerirán un episodio depresivo. Es necesario evaluar el papel desempeñado por el ser querido fallecido en la vida del paciente y los recursos externos o internos de los que dispone.

Trastornos psiquiátricos en personas mayores

Existen dos tipos de trastornos psiquiátricos en las personas mayores: los trastornos psiquiátricos que aparecen a una edad más temprana y progresan con el envejecimiento y los trastornos psiquiátricos que aparecen a una edad avanzada. El diagnóstico de los trastornos psiquiátricos se basa en las mismas definiciones que para los adultos, es decir, **criterios relativos al número de síntomas, la duración y la ruptura con el estado anterior**. La **depresión** es el trastorno más frecuente, afecta al 4% de la población mayor de 65 años y hasta al 10% de las personas internadas en instituciones. La pérdida de autonomía, las comorbilidades médicas y los factores de estrés social pueden explicar esta elevada prevalencia. Las características clásicas de la depresión en las personas ancianas se resumen en el **Cuadro 1**.

Cuadro 1.
Diferencias semiológicas sugestivas entre el «síndrome de deslizamiento» y la depresión «clásica» en los ancianos.

	Síndrome de deslizamiento	Depresión
Contexto de aparición	Tras recuperarse de un trastorno	Factor de estrés ambiental o ausencia de factor desencadenante
Estado de ánimo	No expresado	Tristeza, irritabilidad
Actividad reducida	Regresión psicomotriz	Pérdida de interés
Actitudes de oposición	Pronunciadas	Posibles
Funciones instintivas	Anorexia, adipisia	Anorexia, insomnio
Trastornos cognitivos	No expresados	Problemas de memoria Dificultades de concentración
Ansiedad	No expresada	Consulta ansiosa
Cogniciones depresivas	No expresadas	Baja autoestima Ideas suicidas
Síntomas físicos	Atonía intestinal y vesical Trastornos posturales	Actitudes hipocondríacas
Síntomas psicóticos	Ninguno	Ideas delirantes Alucinaciones
Pronóstico	Riesgo vital a corto plazo	Mejora con los cuidados adecuados

Cabe señalar que las cogniciones depresivas y la ideación suicida se expresan menos en los ancianos que en los adultos más jóvenes, aunque el riesgo de intentos de **suicidio** es mayor. Las personas mayores presentan más expresiones conductuales de depresión (apatía, insomnio e irritabilidad), así como más trastornos cognitivos, ansiosos y en particular somáticos que los adultos más jóvenes. La prevalencia de los trastornos de ansiedad se estima en un 10% en las personas ancianas; el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son los más frecuentes. Cabe señalar que la depresión y los trastornos de ansiedad de aparición tardía suelen asociarse a enfermedades no psiquiátricas de forma bidireccional. Las **enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares** aumentan el riesgo de desarrollar un episodio depresivo típico y, a la inversa, un episodio depresivo típico aumenta el riesgo de aparición o agravación de algunas enfermedades no psiquiátricas [7]. El trastorno bipolar y la esquizofrenia de inicio tardío son poco frecuentes: se estiman en un 0,1% de la población.

Trastornos neurocognitivos menores y mayores

Los trastornos neurocognitivos (TNC) menores y mayores hacen referencia a diferentes etapas en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. El TNC menor corresponde a un deterioro cognitivo sin repercusiones en la autonomía. El TNC mayor, o «demencia» en la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 (CIE-11), se refiere a un deterioro cognitivo que repercute en la autonomía de la persona [8]. Los TNC se definen mediante criterios sindrómicos comunes, aunque están causados por procesos neurodegenerativos variables. Los TNC se acompañan de SSP a lo largo de su evolución, parte integrante del cuadro clínico de la demencia [9]. No se trata de simples comorbilidades psiquiátricas: están presentes en más del 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer o trastornos relacionados. En la fase de TNC menor, los SSP puede confundirse con un trastorno psiquiátrico y provocar un retraso en el tratamiento de la enfermedad neurodegenerativa, con todas las consecuencias funcionales que ello conlleva. En la fase de TNC mayor, la identificación de los SSP pasa por la necesidad de superar los déficits cognitivos del paciente, además del tratamiento sintomático de los SSP.

Estos síntomas suelen manifestarse en una fase precoz. Son responsables en gran medida del agotamiento de cuidadores y familiares y constituyen el motivo más frecuente de ingreso en una institución. Los cambios más frecuentes y precoces son los llamados síntomas de retraimiento: apatía y manifestaciones depresivas. Su prevalencia se estima en un 50% en la demencia [10].

Los síntomas psicóticos (delirios, alucinaciones visuales) también son frecuentes y aparecen más tarde en los TNC mayores. Cabe señalar que los delirios pueden estar relacionados con perturbaciones de la identificación, es decir, una interpretación errónea del contexto vinculada a alteraciones de la memoria y sensoriales (creencia delirante del paciente de que le roban sus objetos o de que un extraño vive en su casa).

Síndrome de deslizamiento

Cabe destacar la situación específica del «síndrome de deslizamiento», que debe evocarse en presencia de apatía cuando una evaluación etiológica resulta negativa. Este término es objeto de debate en la comunidad médica, ya que a menudo se utiliza mal cuando los pacientes se oponen pasivamente a la alimentación, la movilización o el tratamiento, lo que conduce de forma errónea a la interrupción de las investigaciones etiológicas y al inicio de cuidados «paliativos». En este artículo no se toma partido más que por la urgencia médica asociada a este cuadro y se intenta reflejar el estado actual de las publicaciones. La clínica es la de una **regresión psicomotriz** que aparece tras un **intervalo libre** después de una **enfermedad aguda que ha curado sin más signos clínicos o de laboratorio**. La regresión psicomotriz incluye trastornos posturales estáticos (postura rígida, dificultad para permanecer en la silla con deslizamiento), trastornos posturales dinámicos (temblor al levantarse, tendencia a caerse), trastornos (enlentecimiento ideatorio, pérdida de iniciativa, trastornos de la memoria), pérdida de autonomía (incapacidad para comer solo, clinofilia, dependencia de los pañales, etc.). Las perturbaciones vegetativas como la suboclusión o la retención urinaria suelen complicar la inactividad prolongada. Pueden presentarse **actitudes de oposición** como mutismo y rechazo de la comida. La exploración neurológica no revela signos de síndrome extrapiramidal, cerebeloso o vestibular ni signos sugestivos de un estado multilacunar (risa/llanto espasmódicos, problemas de deglución, etc.). El pronóstico es malo, lo que requiere un **tratamiento urgente** y una **reevaluación periódica** de las medidas adoptadas. Este síndrome puede ser difícil de diferenciar de la depresión (Cuadro 1) y no siempre responde a los antidepresivos. Sin embargo, debe considerarse la evaluación del estado de ánimo y, en ocasiones, la instauración de tratamientos antidepresivos adecuados. Como es de rigor en el caso de los ancianos, las medidas preventivas para detectar y evitar las causas de la inmovilización son las más eficaces. Entre ellas, evitar las perfusiones, el reposo continuo en cama que no se reevalúa, el confinamiento y las sujeciones, la protección sistemática y la pérdida de contacto social.

Cuadro 2.

Situaciones clínicas comunes y principios de tratamiento específicos para los síntomas psiquiátricos frecuentes en los ancianos.

Síntomas psiquiátricos	Situaciones clínicas	Cuidados específicos
Agitación	• Incipiente • Confusión o trastorno neurocognitivo	• Desescalada • Ayuda a la reorientación, implicación de la familia y amigos, antipsicóticos (loxapina, risperidona), resincronización día-noche (melatonina)
Ansiedad	• Dificultades adaptativas: origen cognitivo, personalidad, discapacidad • Trastorno psiquiátrico: depresión o trastorno de ansiedad • Síntomas diana, de tipo ataque de pánico	• Adaptación del entorno con la ayuda de los familiares y el equipo asistencial • Tratamiento con antidepresivos (sertralina, escitalopram) y psicoterapia (cognitivo-conductual) • Benzodiazepinas de semivida corta en caso de síntomas diana (oxazepam)
Apatía	• Trastorno neurocognitivo mayor • Depresión	• Evaluación neuropsicológica, ayuda a la movilización y estimulación adecuada • Tratamiento con antidepresivos, psicoterapia ± ansiolíticos en caso de síntomas diana
Ideas suicidas	• Fuentes de estrés (dolor, discapacidad) • Sesgo de juicio: trastorno neurocognitivo o depresión • Comunicación disfuncional	• Resolver la fuente de estrés • Adaptación de ayudas, psicoterapia, en caso de depresión: antidepresivos ± ansiolíticos en caso de síntomas diana • Identificar los problemas de relación y cómo resolverlos
Síntomas psicóticos	Ideas delirantes, alucinaciones	Antipsicóticos antiproduktivos como risperidona, olanzapina, loxapina, clozapina en caso de síndrome parkinsoniano asociado
Trastornos de las funciones instintivas	• Trastornos del sueño • Anorexia • Desinhibición conductual (sexualidad, hiperfagia)	• Medidas higiénicas, tratamiento del síndrome de apnea del sueño, melatonina • Estimulación adecuada • Identificación del contexto de aparición, solución con el equipo asistencial y los familiares, antipsicótico antiimpulsivo de tipo risperidona a dosis bajas

■ Principios de tratamiento (Cuadro 2)

Dado que los SSP tiene un origen multifactorial, debe investigarse desde un punto de vista etiológico, implicando tanto al paciente como a sus acompañantes. Consiste en una **caracterización semiológica** de los trastornos (en particular para distinguir los delirios de las perturbaciones de la identificación), una evaluación del **estado cognitivo, médico no psiquiátrico** y **ambiental** del paciente (cambios en las condiciones de vida y acontecimientos vitales estresantes), una evaluación del **grado de urgencia, peligrosidad o riesgo funcional** y de la **repercusión en los cuidadores**. Deben buscarse primero las causas médicas no psiquiátricas y los factores de riesgo de SSP.

Tratamiento médico de la etiología y los factores precipitantes

Es preciso identificar y resolver los factores precipitantes de SSP. Las medidas preventivas siguen siendo las intervenciones más eficaces para reducir la incidencia y la gravedad de los SSP. Por sí solas reducen el riesgo de confusión en un 30-50%. Incluyen **ayudas a la orientación** (relojes, efemérides, contextualización de los intercambios a los acontecimientos que preocupan al paciente, animar a los pacientes a seguir las noticias del día), **corrección de los déficits sensoriales, aporte nutricional e hidratación**, dar prioridad a la alimentación enteral, comprobar la higiene bucal y la ausencia de micosis, identificar y tratar el dolor, regular los **ciclos sueño-vigilia, movilización precoz e implicación del entorno social** [11]. En el «síndrome de deslizamiento» en particular, debe añadirse con regularidad el **tratamiento de las complicaciones asociadas a la inmovilización**: reevaluación de los tratamientos para la atonía vesical e intestinal (anticolinérgicos), cuidado de heridas y escaras, kinesiología para la rigidez articular, la espasticidad o la amiotrofia muscular, rehabilitación cardíaca y respiratoria, prevención de la enfermedad tromboembólica venosa y suplementos vitamínicos para corregir la desmineralización ósea. Como norma general, debe tratarse cualquier enfermedad psiquiátrica documentada.

Medidas medicosociales

En caso de pérdida de autonomía o de trastornos de conducta en el domicilio, el contacto con los **sistemas de apoyo a la coordinación** [12], que incluyen modalidades de actuación para la integración de los servicios de asistencia, plataformas territoriales de apoyo y redes sanitarias, permitirá reevaluar el acondicionamiento de la vivienda y la asistencia humana que puede movilizarse. Estos programas también ofrecen apoyo a los cuidadores a través de centros locales de información y coordinación.

Apoyo a los cuidadores

La implicación de los cuidadores y del personal de las residencias puede reducir la frecuencia y gravedad de los trastornos de conducta, así como la prescripción de psicótopos [13]. Facilitar **información** sobre la enfermedad y concienciar sobre las **técnicas de comunicación** puede ayudar a desactivar algunos problemas [14]. Es fundamental que se **planifiquen y respeten los ritmos individuales**, que los horarios sean regulares, que el personal sea estable y que se organicen actividades individuales o en grupo que se adapten a los perfiles, necesidades y gustos de los residentes. Las medidas terapéuticas conductuales deben enseñarse a los profesionales: elogiar, reforzar la conducta deseada, ignorar la conducta no deseada, dar la opinión sobre la conducta inadecuada. Las técnicas para mejorar la comunicación son eficaces: limitar las fuentes de distracción (televisión, radio), hablar cara a cara, transmitir un mensaje cada vez, utilizar frases cortas y preguntas cerradas, repetir las frases si es necesario y hacer hincapié en el lenguaje corporal.

Tratamiento psiquiátrico sintomático

Se elige en función de los síntomas **diana** (agitación, ansiedad, delirios) y de forma **transitoria**. El tratamiento de la causa, incluidas las causas psiquiátricas, es fundamental. En las personas ancianas, todos estos tratamientos deben iniciarse a la mitad de la dosis y luego aumentarse de forma gradual en función de la tolerabilidad. Deben preferirse los neurolepticos, a pesar de sus

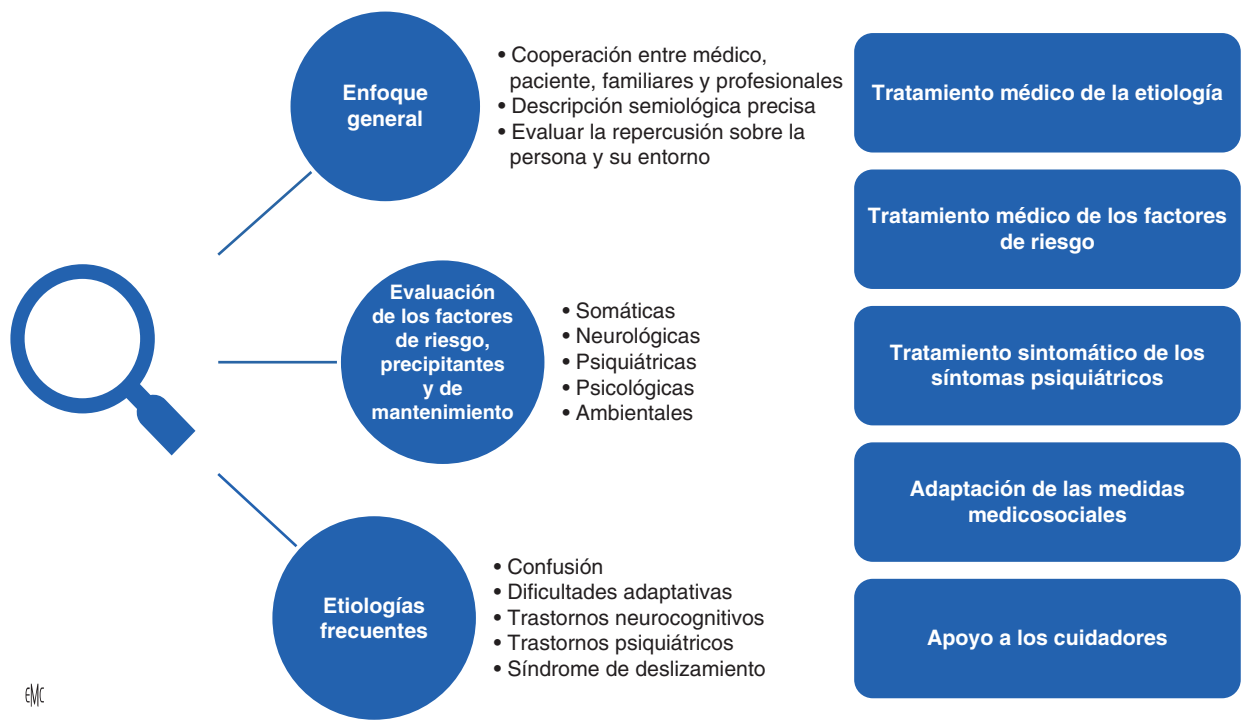


Figura 1. Principios de evaluación clínica y tratamiento de los signos y síntomas psiquiátricos en personas ancianas.

efectos anticolinérgicos. Si se utilizan benzodiazepinas, en caso de ansiedad o contraindicación a los neurolepticos, deben preferirse las de semivida corta (oxazepam), vigilando al mismo tiempo el riesgo de confusión.

Los principios de la evaluación clínica y el tratamiento se resumen en la [Figura 1](#).

■ Ejemplos de signos y síntomas psiquiátricos frecuentes

El abanico de etiologías subyacentes a los SSP en las personas mayores es vasto y heterogéneo, y la respuesta terapéutica varía en sus efectos, por lo que cualquier observación realizada de forma desordenada no conducirá a una mejora duradera de los trastornos. Hay que proceder con cautela y método y tratar de respetar tres principios generales:

- **pensar en términos de síndromes**, buscando criterios suficientes a favor de una entidad clínica;
- pensar en **cinco ejes cardinales**: los síntomas, la pérdida de autonomía, la depresión, la iatrogenia y el entorno social;
- utilizar **psicótrópos sólo si existe un objetivo claro**, evitando los tratamientos «a ciegas» o inadecuados en cuanto a dosis y duración.

En esta sección se ilustra cómo pueden aplicarse estos distintos principios a los SSP frecuentes en las personas mayores.

Agitación

Una revisión de los antecedentes y el contexto en el que se produjo la agitación apunta a su causa y a los factores precipitantes. Cualquier agitación debe revisarse en primer lugar para detectar la confusión y sus causas. En los TNC, la desinhibición puede conducir a la agitación, sobre todo en caso de frustración. En la demencia frontotemporal, la desinhibición puede adoptar diversas formas: pérdida del decoro social, lenguaje grosero o hiriente inapropiado, hiperoralidad (potomanía, alcoholismo de inicio tardío, hiperfagia), conducta delictiva (robo, exceso de velocidad), impaciencia con aversión a la demora, etc. La anosognosia, el deterioro de la función ejecutiva y los déficits de cognición social suelen asociarse a la desinhibición. Ante una agitación incipiente,

se pueden aplicar técnicas de desescalada manteniendo un intercambio verbal, tranquilizando (reorientación temporoespacial) y distrayendo de cualquier preocupación que provoque ansiedad. Estas medidas se acompañan de una expresión tranquila, gestos lentos y distanciamiento para respetar el espacio del paciente ^[14].

Ansiedad

Los síntomas de ansiedad son frecuentes en las personas mayores, en particular los síntomas físicos causados por la hiperactividad del sistema simpático (palpitaciones, cefaleas, mialgias, mareos). En general, la ansiedad surge de las dificultades de adaptación al entorno, cuyas causas pueden ser múltiples. Los trastornos cognitivos pueden subyacer a estas dificultades de adaptación, por desorientación o falta de comprensión del entorno o de las acciones de los cuidadores. La confusión o el TNC pueden producir este tipo de ansiedad, en cuyo caso las medidas para paliarla serán las indicadas para estos trastornos, en particular la adaptación del entorno a la persona.

También hay que tener en cuenta la personalidad del paciente, comprendiendo sus reacciones emocionales y sus patrones de apego, tanto los habituales como los que surgen a medida que envejece. La ansiedad puede ser el modo de comunicación preferido de los pacientes que buscan ayuda. Tener en cuenta los factores de estrés actuales y la historia vital puede ser útil para establecer un vínculo con el paciente y adaptar el apoyo. La psicoterapia de apoyo puede ser suficiente para ayudar a los pacientes sin comorbilidad asociada.

Por último, la ansiedad puede ser un signo de un trastorno psiquiátrico en sí mismo. Como se señala en el [Cuadro 1](#), la depresión en las personas mayores tiende a estar relacionada con la ansiedad, con actitudes hipocondríacas y una preocupación desproporcionada por los factores de estrés actuales, que puede evolucionar hacia la melancolía si no se trata. Se recuerda que los síntomas de un episodio depresivo deben durar al menos 2 semanas y representar una ruptura con el estado anterior. Por el contrario, el trastorno de ansiedad generalizada, frecuente en las personas mayores, implica preocupaciones ansiosas que afectan a muchas áreas de la vida del paciente y duran más de 6 meses. El trastorno de ansiedad generalizada se encuentra de forma preferente en pacientes con una personalidad ansiosa premórbida.

Sea cual sea el trastorno, debe darse prioridad al tratamiento de los factores que mantienen los SSP. Una evaluación neuropsicológica es importante para identificar cualquier trastorno y proponer una psicoterapia personalizada o programas de remediación cognitiva. Las terapias cognitivo-conductuales han demostrado ser eficaces para restablecer el control emocional intacto o iniciar terapias específicas ^[15] en función de los trastornos del paciente (por ejemplo, terapias de exposición para las fobias). Por último, los antidepresivos pueden considerarse en caso de síntomas incapacitantes, para que el paciente esté disponible desde el punto de vista psíquico para la terapia, o si el paciente presenta un deterioro cognitivo excesivo. Las benzodiazepinas pueden considerarse en caso de ataques de pánico o insomnio causado por rumiaciones ansiosas. En estos casos, son preferibles los de semivida corta, como el oxazepam.

Apatía

La apatía es una falta de iniciativa espontánea con una reducción de la conducta dirigida a un objetivo. Es la modificación conductual más común en los TNC ^[16]. La persona puede ser capaz de llevar a cabo las acciones que se le piden en el momento de la estimulación, pero es incapaz de mantenerlas a lo largo del tiempo. En la demencia frontotemporal, la apatía corresponde al lado deficitario del síndrome frontal, asociado al deterioro de las funciones ejecutivas. El diagnóstico diferencial entre depresión y apatía de TNC no siempre es obvio. Los signos a favor de un episodio depresivo caracterizado son: una ruptura brusca con el estado anterior, consultas ansiosas que tienden a ser de naturaleza hipocondríaca, tristeza y presencia de factores de estrés ^[17]. Deben cumplirse los criterios de duración de un episodio depresivo, así como la ausencia de asociación con confusión. La presencia de un episodio depresivo no excluye un trastorno que explique las manifestaciones somáticas, la discapacidad (física o social) o un TNC, en particular con un riesgo cardiovascular elevado. El tratamiento con un antidepresivo puede iniciarse en caso de depresión, con la norma de comenzar con una dosis baja e ir aumentando de forma progresiva hasta conseguir una respuesta, incluso con una dosis elevada. La necesidad de una evaluación neuropsicológica para identificar las facultades afectadas y las que están intactas permitirá proponer programas de remediación cognitiva y estimulación adecuados. Hay que evitar la sobreestimulación, teniendo en cuenta los deseos y las capacidades de los pacientes.

Ideas suicidas

La ideación suicida suele ser un signo de estrés desbordado. Además de evaluar su presencia, es importante identificar sus causas, sociales, médicas o psiquiátricas (cogniciones depresivas), para resolver la crisis suicida. La ideación suicida debe impulsar la identificación de otros trastornos que puedan estar precipitando la crisis al interferir con la capacidad del paciente para emitir juicios serenos. Estos problemas pueden incluir confusión, dolor intenso, insomnio persistente, alteración del estado general o depresión.

Síntomas psicóticos

En caso de antecedentes de enfermedad psiquiátrica, es preciso conocer el curso evolutivo, la frecuencia de las descompensaciones y sus manifestaciones clínicas habituales. En las personas ancianas, hay que distinguir entre delirios, perseveración de ideas irracionales o trastornos del juicio con discurso incoherente, secundarias al deterioro de la memoria y de las funciones ejecutivas. En los TNC, la amnesia, que corresponde a la reactualización de viejos recuerdos y hábitos (el deseo de recoger a los hijos del colegio o de ir a trabajar), no es un delirio y no debe tratarse como tal. Además, la intolerancia a la frustración combinada con la falta de comprensión de las acciones de los cuidadores puede dar lugar a reproches inapropiados que no son sinónimo de delirios de persecución. Asimismo, como consecuencia de la desafrentación sensorial, los trastornos visuales pueden favorecer las alucinaciones visuales, mientras que los déficits auditivos aumentan el riesgo de interpretaciones delirantes ^[18].

En la enfermedad de Alzheimer, los delirios de robo y persecución suelen ser consecuencia de trastornos de la memoria y el juicio. Constituyen una racionalización de la pérdida de objetos o del olvido y se producen con preferencia al inicio de la enfermedad. Las alucinaciones, por lo general visuales, pero a veces auditivas, son tardías y se asocian a una evolución poco favorable desde el punto de vista cognitivo, funcional y conductual.

Las alucinaciones visuales son uno de los cuatro principales criterios diagnósticos de la enfermedad de los cuerpos de Lewy ^[19]. Se producen al principio de la enfermedad, entre el 50-80% en estadios incipientes ^[20]. Estas alucinaciones, que suelen ser estereotipadas y repetitivas, suelen referirse a animales o seres humanos. Pueden experimentarse con intensidad y acompañarse de conductas perturbadoras o arrebatos ansiosos. Los delirios, que se dan en el 40-60% de los pacientes, suelen implicar celos o persecución y pueden ser congruentes con el escenario alucinatorio ^[21]. En esta afección son frecuentes los trastornos de identificación, como el signo televisivo (indistinción entre imágenes y realidad) o el síndrome del inquilino fantasma.

También pueden encontrarse síntomas psicóticos en la demencia frontotemporal, en un 10-20% de los casos. Las ideas delirantes son de naturaleza polimorfa, asociadas a perseveración de ideas religiosas o hipocondríacas. Se han descrito alucinaciones visuales o auditivas en las formas genéticas ^[22].

Trastornos de las funciones instintivas

Los trastornos del sueño tienen un impacto considerable en el control emocional al reducir la vigilancia diurna. Los mecanismos varían en función del trastorno: rumiaciones que causan insomnio en la depresión, desincronización del ciclo nocturno en los TNC o las confusiones. Los trastornos de conducta durante el sueño paradójico son uno de los principales criterios de la enfermedad de los cuerpos de Lewy ^[19]. También puede haber comorbilidades como la apnea del sueño o el síndrome de las piernas inquietas. Es importante conocer el patrón de sueño previo de la persona (sueño corto/largo; sueño tardío/levantarse temprano) para estimar la gravedad de las perturbaciones. Sea cual sea el trastorno, la pérdida de exposición a los sincronizadores del reloj biológico (alternancia de luz y oscuridad, actividad física, relaciones sociales) puede mantener los trastornos del sueño. En los pacientes apáticos, la hipersomnia diurna contribuye al insomnio al reducir la necesidad de sueño nocturno. La corrección del insomnio por sí sola puede reducir de forma significativa los SSP. Es preferible adoptar medidas higiénicas. La melatonina de liberación prolongada es el tratamiento de elección porque es seguro y respeta las fases del sueño.

Las causas de la anorexia son similares a las de la apatía, con énfasis en los dolores o náuseas de origen digestivo o medicamentoso. Las actitudes de desinhibición como la hiperfagia o la hipersexualidad pueden encontrarse en el síndrome frontal de los TNC o en un síndrome maniaco. En los TNC (demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer), el término «conducta sexual inapropiada» puede adoptar diversas formas: comentario verbal, conducta sin contacto con los demás, exhibición o conducta con contacto con los demás ^[23]. Aparte del síndrome maniaco, se sabe poco sobre el tratamiento de la conducta sexual inapropiada. Identificar los factores que provocan estos trastornos puede ayudar a reducir su frecuencia. Puede tratarse de momentos específicos del día que guían la instauración de un tratamiento, la presencia de algunos cuidadores, el uso de ropa que se desprende con facilidad y que el paciente no puede volver a ponerse, etc. Las medidas conductuales pueden probarse caso por caso, centrándose en las conductas consideradas inaceptables e implicando a los familiares y cuidadores ^[24]. Puede administrarse un tratamiento antipsicótico antiimpulsivo, como la risperidona a dosis bajas.

■ Conclusión

En los pacientes ancianos, la clínica psiquiátrica es variada y a menudo perturbadora para la familia y los cuidadores. Existe un gran riesgo de conformarse con un diagnóstico aproximado,

pasar por alto una etiología y responder de forma urgente e inadecuada con un uso excesivo de psicótopos sedantes. Para cada situación es necesaria la anamnesis y hay que resumir las manifestaciones semiológicas, examinar las relaciones pasadas y presentes y cuestionar la conveniencia de la polimedicación.

En las personas ancianas, el uso de psicótopos debe considerarse con cuidado y moderación. Es fundamental establecer y mantener el contacto con las personas de su entorno. Es necesario escuchar, explicar y, si es posible, tranquilizar. También es importante, tras reflexionar y explicar, permitir que se mantengan o restablezcan las relaciones. Todas las cuestiones planteadas, relativas al futuro inmediato y a largo plazo, deben abordarse en presencia del paciente y de forma eficaz por el médico. Esta ayuda práctica a los pacientes y a sus cuidadores presupone el conocimiento de los sistemas especializados de apoyo geriátrico a los que todos los médicos pueden remitir a los pacientes.

Por último, no todos los trastornos de conducta ni todos los sufrimientos psíquicos son necesariamente problemas médicos, y rara vez lo son de forma exclusiva. La evaluación metódica de los motivos de consulta permite distinguir las entidades médicas del sufrimiento psicosocial, cuya problemática va más allá de un excesivo formalismo biomédico. El papel del médico en estas situaciones debe ser claro y permitirle apoyar las peticiones de los pacientes o cuidadores a las autoridades competentes en situaciones sociales complejas, manteniendo al mismo tiempo la vigilancia médica. También hay que recordar que, aunque los médicos desempeñan un papel importante en la evaluación de la autonomía de los pacientes, nunca son quienes toman las decisiones cuando se trata de las opciones vitales de éstos, que son individuos de derecho, incluida la persona protegida. Así pues, aunque a menudo se recurre a los médicos en primera instancia en caso de SSP, la resolución a largo plazo del sufrimiento psicológico de las personas mayores suele ser el resultado de una acción coordinada entre los pacientes, los cuidadores, los trabajadores sociales y los médicos implicados.

■ Bibliografía

- [1] Institute of Health Metrics and Evaluation. *Global Health Data Exchange.(GHDx)*.
- [2] Dorey JM, Herrmann M, Schuster JP, von Gunten A, Lepetit A. Stratégies thérapeutiques des troubles psychocomportementaux dans les troubles neuro-cognitifs de la personne âgée. *EMC Psychiatrie* 2019;1–13.
- [3] Osborne H, Simpson J, Stokes G. The relationship between pre-morbid personality and challenging behaviour in people with dementia: a systematic review. *Aging Ment Health* 2010;14:503–15.
- [4] Noone D, Stott J, Aguirre E, Llanfear K, Spector A. Meta-analysis of psychosocial interventions for people with dementia and anxiety or depression. *Aging Ment Health* 2018;23:1282–91.
- [5] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Delirium: prevention, diagnosis and management in hospital and long-term care. Clinical guideline (CG103)*, 2023.
- [6] American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5*. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
- [7] Richmond-Rakerd LS, D’Souza S, Milne BJ, Caspi A, Moffitt TE. Longitudinal associations of mental disorders with dementia: 30-year analysis of 1.7 million New Zealand citizens. *JAMA Psychiatry* 2022;79:333–40.
- [8] *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 11^e version*. <https://www.cihi.ca/fr/normes-et-soumission-de-donnees/codification-et-classification/cim-11-classification-statistique>.
- [9] Finkel SI, Silva JC, Cohen GD, Miller S, Sartorius N. Behavioral and psychological symptoms of dementia: a consensus statement on current knowledge and implications for research and treatment. *Int Psychogeriatr* 1996;8:497–500.
- [10] Johnson DK, Watts AS, Chapin BA, Anderson R, Burns JM. Neuropsychiatric profiles in dementia. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2011;25:326–32.
- [11] HAS. *Recommandations de bonne pratique. Confusion aiguë chez la personne âgée : prise en charge initiale de l’agitation*. 2009. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-07/confusion_aigue_chez_la_personne_agee_-_recommandations.2009-07-08_16-58-24.661.pdf.
- [12] Ministère de la Santé et de la Prévention. *Les dispositifs d’appui à la coordination (DAC)*. <https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/structures-de-soins/les-dispositifs-d-appui-a-la-coordination-dac/>.
- [13] Parker D, Mills S, Abbey J. Effectiveness of interventions that assist caregivers to support people with dementia living in the community: a systematic review. *JB Libr Syst Rev* 2008;6:484–544.
- [14] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings. NICE guideline (NG10)*, 2015.
- [15] Noone D, Stott J, Aguirre E, Llanfear K, Spector A. Meta-analysis of psychosocial interventions for people with dementia and anxiety or depression. *Aging Ment Health* 2019;23:1282–91.
- [16] Hallikainen I, Hongisto K, Välimäki T, Hänninen T, Martikainen J, et al. The progression of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease during a five-year follow-up: Kuopio ALSOVA study. *J Alzheimers Dis* 2018;61:1367–76.
- [17] Schaakxs R, Comijs HC, Lamers F, Beekman ATF, Penninx BWJH. Age-related variability in the presentation of symptoms of major depressive disorder. *Psychol Med* 2017;47:543–52.
- [18] Kiely KM, Mortby ME, Anstey KJ. Differential associations between sensory loss and neuropsychiatric symptoms in adults with and without a neurocognitive disorder. *Int Psychogeriatr* 2018;30:261–72.
- [19] McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW, Halliday G, Taylor JP, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: fourth consensus report of the DLB Consortium. *Neurology* 2017;89:88–100.
- [20] Johnson DK, Watts AS, Chapin BA, Anderson R, Burns JM. Neuropsychiatric profiles in dementia. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2011;25:326–32.
- [21] Ballard C, Holmes C, McKeith I, Neill D, O’Brien J, et al. Psychiatric morbidity in dementia with Lewy bodies: a prospective clinical and neuropathological comparative study with Alzheimer’s disease. *Am J Psychiatry* 1999;156:1039–45.
- [22] Tang L, Wang Y, Chen Y, Chen L, Zheng S, et al. The association between 5HT2A T102C and behavioral and psychological symptoms of dementia in Alzheimer’s disease: a meta-analysis. *Biomed Res Int* 2017;2017:5320135.
- [23] Higgins A, Barker P, Begley CM. Hypersexuality and dementia: dealing with inappropriate sexual expression. *Br J Nurs* 2004;13:1330–4.
- [24] Joller P, Gupta N, Seitz DP, Frank C, Gibson M, et al. Approche pour les comportements sexuels inappropriés chez des personnes atteintes de démence. *Can Fam Physician* 2013;59:255–60.

J.-C. Roy, Chef de clinique des universités, assistant hospitalier (jc.roy@ch-guillaumeregner.fr).

Pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie adulte, Centre hospitalier universitaire de Rennes, 2 rue Henri Le Guilloux, 35000 Rennes (France).

G. Robert, Professeur des universités, praticien hospitalier.

Pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie adulte, Centre hospitalier Guillaume Régner, 108 avenue du Général Leclerc, 35703 Rennes (France).

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Roy JC, Robert G. Síntomas psiquiátricos más frecuentes en personas mayores. *EMC - Tratado de medicina* 2024;28(3):1-7 [Artículo E – 3-1100].